



Collection MedWIZ

5<sup>e</sup> année médecine

# GYNÉCOLOGIE- OBSTÉTRIQUE

Wisdom. Innovation. Zeal.



CET OUVRAGE APPARTIENT À

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Université / Faculté : \_\_\_\_\_

Matricule du BAC : \_\_\_\_\_

Année universitaire : \_\_\_\_\_

N° de téléphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

# AVANT- PROPOS

---

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

## NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

# WIZ TRACKER

## I. Cours :

| N° | Intitulé du cours                                | Page | Col | C02 | C03 | QCM |
|----|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 01 | Cycle menstruel et ses troubles                  | 8    |     |     |     |     |
| 02 | Fécondation naturelle                            | 10   |     |     |     |     |
| 03 | Diagnostic de la grossesse                       | 12   |     |     |     |     |
| 04 | Infertilité du couple                            | 14   |     |     |     |     |
| 05 | Aménorrhées primaire et secondaire               | 16   |     |     |     |     |
| 06 | Avortements spontanés                            | 20   |     |     |     |     |
| 07 | Grossesse extra-utérine (GEU)                    | 22   |     |     |     |     |
| 08 | Maladies trophoblastiques gestationnelles        | 24   |     |     |     |     |
| 09 | Dépistage des grossesses à haut risque           | 26   |     |     |     |     |
| 10 | Mécanisme d'accouchement                         | 28   |     |     |     |     |
| 11 | Présentation du sommet et accouchement           | 30   |     |     |     |     |
| 12 | Présentation du siège                            | 32   |     |     |     |     |
| 13 | Présentations de la face, du front et transverse | 36   |     |     |     |     |
| 14 | Délivrance normale et pathologique               | 38   |     |     |     |     |
| 15 | Suites de couches normales et pathologiques      | 40   |     |     |     |     |
| 16 | Menace d'accouchement prématuré (MAP)            | 44   |     |     |     |     |
| 17 | Placenta prævia                                  | 46   |     |     |     |     |
| 18 | Hématome rétro-placentaire (HRP)                 | 48   |     |     |     |     |
| 19 | HTA et grossesse                                 | 50   |     |     |     |     |
| 20 | Diabète et grossesse                             | 54   |     |     |     |     |
| 21 | Allo-immunisation fœto-maternelle érythrocytaire | 56   |     |     |     |     |
| 22 | Infections et grossesse                          | 58   |     |     |     |     |
| 23 | Souffrance fœtale aiguë (SFA)                    | 60   |     |     |     |     |
| 24 | Rupture utérine                                  | 62   |     |     |     |     |
| 25 | Contraception                                    | 64   |     |     |     |     |
| 26 | Algies pelviennes aiguës                         | 68   |     |     |     |     |
| 27 | Algies pelviennes chroniques                     | 70   |     |     |     |     |
| 28 | Infection génitale haute (IGH)                   | 72   |     |     |     |     |
| 29 | Endométriose                                     | 74   |     |     |     |     |
| 30 | Fibrome utérin                                   | 76   |     |     |     |     |
| 31 | Prolapsus génital                                | 78   |     |     |     |     |
| 32 | Ménopause                                        | 80   |     |     |     |     |
| 33 | Cancer du col de l'utérus                        | 82   |     |     |     |     |
| 34 | Cancer de l'endomètre                            | 84   |     |     |     |     |
| 35 | Tumeurs de l'ovaire                              | 86   |     |     |     |     |
| 36 | Cancers du sein                                  | 88   |     |     |     |     |

## II. Travaux dirigés :

| N° | Intitulé du cours                                          | Page | Col | C02 | C03 | QCM |
|----|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 37 | Explorations complémentaires en gynécologie                | 92   |     |     |     |     |
| 38 | Exploration clinique et paraclinique du bassin obstétrical | 96   |     |     |     |     |
| 39 | Manœuvres obstétricales                                    | 100  |     |     |     |     |
| 40 | Hémorragie de la délivrance                                | 102  |     |     |     |     |
| 41 | Curage utérin                                              | 104  |     |     |     |     |
| 42 | Curetages utérins                                          | 106  |     |     |     |     |

# Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

# CYCLE MENSTRUEL ET SES TROUBLES

## I. DÉFINITION

- Modifications anatomiques et physiologiques récurrentes préparant à la grossesse
- Début : puberté → Fin : ménopause
- Durée :  $28 \pm 7$  jours (1<sup>er</sup> jour = 1<sup>er</sup> jour des règles)
- Contrôlé par l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien

## II. PHYSIOLOGIE

### A. ACTEURS PRINCIPAUX

- Hypothalamus : sécrète la GnRH de façon pulsatile (contrôle FSH/LH)
- Hypophyse : sécrète FSH (maturation folliculaire) et LH (déclenche ovulation)
- Ovaires : fonction endocrine (œstrogènes, progestérone, androgènes) et exocrine (ovulation)
- Endomètre : hormonodépendant (œstrogènes = prolifération, progestérone = sécrétion)

### B. CYCLE OVARIEN

1. Phase folliculaire : croissance folliculaire sous FSH, sécrétion d'œstrogènes
2. Ovulation (J14) : pic de LH déclenché par rétrocontrôle positif des œstrogènes
3. Phase lutéale : transformation en corps jaune → sécrète progestérone + œstrogènes

### C. CYCLE UTÉRIN

1. Phase proliférative : croissance endométriale sous œstrogènes (J6-J13)
2. Phase sécrétoire : transformation sous progestérone (J14-J28)
3. Phase menstruelle : chute hormonale → ischémie → desquamation → règles

## III. EXPLORATION

- Clinique : interrogatoire, caractères sexuels secondaires
- Courbe thermique : suivi de la température (propriété thermogénique de la progestérone)
- Progestéronémie (J21) :  $> 3$  ng/ml = ovulation,  $> 10$  ng/ml = corps jaune de qualité
- Dosages hormonaux (J2-J5) : FSH, LH, E<sub>2</sub>, AMH (évaluation réserve ovarienne)
- Échographie pelvienne : follicules, endomètre, corps jaune

## IV. ANOMALIES DU CYCLE

| Trouble         | Définition                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Spanioménorrhée | Cycles $> 35$ jours                                     |
| Polyménorrhée   | Cycles $< 21$ jours                                     |
| Hypoménorrhée   | Règles $< 2$ jours / peu abondantes                     |
| Ménorragies     | Règles $> 8$ jours ou $> 80$ mL (Score Higham $> 100$ ) |
| Métrorragies    | Saignements en dehors des règles                        |

### A. CAUSES DES MÉNORRAGIES

- Générales : hépatique, rénale, dysthyroïdie, thrombopénie
- Locales : fibromes, polypes, adénomyose
- Fonctionnelles : dysfonctionnement axiale

### B. MÉTRORRAGIES SELON LE CONTEXTE

- Femme ménopausée = cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire
- Femme en activité génitale :
  - causes gravidiques (avortement, GEU, grossesse molaire...)
  - et non gravidiques (classification FIGO PALM-COEIN)
- Adolescente : souvent par immaturité de l'axe



# FÉCONDATION NATURELLE

## I. DÉFINITION ET LOCALISATION

- Fusion entre un spermatozoïde (gamète mâle) et un ovocyte (gamète femelle) → formation d'un zygote (œuf) avec un nouveau génome.
- Lieu : jonction isthmo-ampullaire de la trompe de Fallope.

## II. PRÉPARATION DES GAMÈTES

### A. OVOCYTE (150-200 µm)

- Entouré de :
  - cellules folliculaires (cumulus, corona radiata)
  - zone pellucide (glycoprotéines)
  - espace pré-vitellin

### B. SPERMATOZOÏDE (60 µm)

- Structure : acrosome, noyau, mitochondries, flagelle
- Spermatogenèse : ~70 jours pour former 16 spermatozoïdes

## III. REMONTÉE DES VOIES GÉNITALES & CAPACITATION

### A. TRAJET

- Vagin → glaire cervicale → utérus → trompe (isthme) → jonction ampullaire

### B. BARRIÈRES SÉLECTIVES

1. Glairer cervicale
2. Glandes utérines
3. Ostiums tubaires  
→ Seulement ~100 spermatozoïdes atteignent l'ovocyte (limite la polyspermie)

### C. CAPACITATION (phénomène réversible)

- But : rendre le spermatozoïde fécondant
- Modifications :
  1. Membranaires : perte de cholestérol, fluidité augmentée
  2. Ioniques : élévation du  $\text{Ca}^{2+}$  intracellulaire
  3. Métaboliques : alcalinisation (entrée de  $\text{HCO}_3^-$ , activation AMPc/PKA)
- Mouvement hyperactif + démasquage des récepteurs à la ZP

## IV. ÉTAPES DE LA FÉCONDATION

1. Traversée de la corona radiata :  
hyaluronidase spermatique dissocie les cellules folliculaires
2. Reconnaissance et fixation à la ZP :  
liaison récepteurs-ligands (hZP3) → spécifique d'espèce
3. Réaction acrosomique (irréversible) :
  - Exocytose du contenu de l'acrosome
  - Libération d'enzymes (hyaluronidase, protéases)
  - Digestion de la ZP → pénétration
4. Liaison et fusion avec la membrane plasmique de l'ovocyte dans l'espace pré-vitellin
5. Incorporation du spermatozoïde (tête, pièce intermédiaire, flagelle)

## V. ACTIVATION OVOCYTAIRE ET DÉVELOPPEMENT ZYGOTIQUE

### A. ACTIVATION PAR ONDE CALCIQUE

- 3 théories : fusion, récepteur, bombe calcique

### B. ACHÈVEMENT DE LA MÉIOSE

- Expulsion du 2<sup>e</sup> globule polaire
- Formation du pronoyau femelle (23 chromosomes)
- Décondensation du noyau spermatique → pronoyau mâle

### C. AMPHIMIXIE (~18h après)

- Réplication de l'ADN des 2 pronoyaux
- Migration au centre → disparition des membranes
- Formation du fuseau (centrosome issu du centriole proximal paternel)  
→ Métaphase de la 1<sup>re</sup> division mitotique

### D. SEGMENTATION

- Blastomères totipotents → blastocyste (5-6 jours)  
→ implantation (nidation)

## VI. ANOMALIES DE LA FÉCONDATION

| TYPE D'ANOMALIE                                                                | CONSÉQUENCE                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Anomalies chromosomiques transmises par un gamète (translocation, trisomie...) | Syndromes génétiques variables   |
| Polyspermie (2 spermatozoïdes)                                                 | Triploïdie                       |
| Erreur de réplication de l'ADN                                                 | Polyploïdie                      |
| Répartition inégale des chromosomes lors de la 1 <sup>re</sup> division        | Anomalies numériques (syndromes) |

## VII. INTÉRÊT EN PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

- ### A. FIV : rencontre gamètes in vitro → zygote → embryon diploïde

### B. INDICATIONS

- Stérilité tubaire définitive
- Hypofertilité masculine
- Glairer hostile (anticorps anti-spermatozoïdes)
- Infertilité idiopathique
- Endométriose

- ### C. AUTRES TECHNIQUES : GiFT, insémination artificielle, fécondation assistée